

La dyspnée aiguë : définition, évaluation clinique et paraclinique

Sortes de dyspnées aiguës (i.e. à début brusque) :

- Dyspnées inspiratoire (haut placé, ex corps étranger ou épiglottite), expiratoire (rétrécissement des bronches, ex asthme ou BPCO), ou aux 2 temps
- Dyspnées à l'effort, au repos
- **Orthopnée** : difficultés respiratoires soulagées en position assise
- **Platypnée** : difficultés respiratoires soulagées en position couchée
- Dyspnée nocturne paroxystique : difficultés respiratoires survenant brusquement dans la nuit. Trouvée chez les patients avec insuffisance cardiaque car en position couchée les œdèmes des membres inf montent et deviennent œdèmes pulmonaires. Cette dyspnée se corrige lorsque la personne se met en position assise ou debout. Ne pas confondre avec l'apnée du sommeil (chez personnes en surpoids, troubles neurologique des centres respiratoires ou avec une mâchoire dont la morphologie permet à la langue de partir en arrière et bloquer les VAS).

Évaluation clinique de la dyspnée aiguë :

I. Antécédents du patient :

- Maladies cardiaques : angor, infarctus, insuffisance cardiaque, cardiopathie congénitale (anatomique)
- Maladies pulmonaires : asthme, allergies, BPCO
- Maladies thromboemboliques : thrombose veineuse profonde (=phlébite) ou embolie pulmonaire
- Tabagisme
- Anémie
- Maladies infectieuses

II. Interrogatoire : premier épisode, circonstances d'apparition, signes associés, modifications avec changement de position, horaire, stade, facteurs déclenchants/aggravants ou soulageants, long séjour en position assise, etc.

III. Examen clinique :

III. a) signes généraux

- Signes vitaux : TA, fréquence cardiaque, température, respiration (fréquence 12-20/min. Une faible amplitude suggère épuisement ou bronchospasme. Une grande amplitude suggère acidose métabolique. On distingue alors la respiration de Kussmaul = dyspnée régulière = acido-cétose diabétique ou IR vs Cheyn Stokes = dyspnée irrégulière = urémie d'origine neurologique)
- Plaie thoracique, signes de thrombose veineuse profonde
- Cyanose
- Signes d'insuffisance cardiaque sévère : tachycardie, râles pulmonaires, galop à auscultation, œdèmes, écume à la bouche
- Signes d'épuisement : tachypnée superficielle (>20/min, alors que bradypnée <12/min), tirage (respiration avec les muscles accessoires, on verra une tension au niveau des sterno-cléido-mastoïdiens et des fossés intercostaux qui se creusent).
- Signes d'encéphalopathie respiratoire : sueur, confusion, agitation
- Collapsus cardio-vasculaire : effondrement de la pression sanguine (Psys <80mmHg). Selon la cause on parle de chocs hypovolémique, cardiaque, anaphylactique (allergies) ou septique (infection)

III.b) signes pulmonaires :

- Tachypnée/bradypnée
- Battement ailes du nez
- Toux, cyanose
- Voie dysphonique
- **Stridor** (dyspnée inspiratoire) ou **sibilances** (dyspnée expiratoire)
- Murmure vésiculaire (stéthoscope) : normal, diminué ou asymétrique (pneumothorax, pleurésie)
- **Râles bronchiques** (secs, entendus aux deux temps mais mieux à l'expiration) ou **crépitants** (comme le son de cheveux dans l'oreille, signe de stase ou foyer infection)

Évaluation paraclinique de la dyspnée aiguë :

I. Gazométrie artérielle :

- ↓pH : acidose respiratoire ou métabolique (signe de gravité)
- ↓PaO₂ : hypoxémie (asthme, OAP, BPCO)
- ↓PaCO₂ : hypocapnie (asthme)
- ↑PaCO₂ : hypercapnie (insuffisance respiratoire chronique)
- ↑HCO₃⁻ : réponse physiologique à l'hypercapnie

II. Biologie sanguine :

- Anémie
- Polyglobulie = polycythémie = érythrocytose : ↑nombre/volume de GR (insuffisance resp chronique)
- Leucocytose (pneumonie)
- D-dimères (élevés si pneumonie ou embolie pulmonaire)
- BNP (brain natriurétique peptide) : élevé lors d'insuffisance cardiaque chronique
- Troponines (élevées en cas d'infarctus)

III. Radiographie thorax :

- Cardiomégalie : cœur fait >1/2 largeur du thorax
- Pneumonie : opacité
- Pleurésie (inflammation plèvre) : peut être sèche ou liquide (ponctionner pour voir si liquide est infectieux, exsudat, transudat etc).
- Pneumothorax : poumon atteint collabé avec absence de vaisseaux, médiastin attiré du côté sain
- Œdème aigu des poumons : infiltrat hilair en ailes de papillon ou pas, avec **lignes de Kerley** (opaques)

IV. ECG : voir cours sur interprétation des ECG

V. Echocardiographie transthoracique :

- Fonction ventricule G : infarctus aigu, cardiomyopathie
- Fonction ventricule D : embolie pulmonaire
- Dilatation cavités droites : embolie pulmonaire, asthme (car peut causer HTP)
- HTA pulmonaire : embolie pulmonaire, BPCO, ICG...
- Valvulopathies : sténose aortique, insuffisance mitrale

VI. Scan thoracique :

- Compression des voies respiratoires : tumeur
- Infiltrat : pneumonie, tumeur
- Traumatisme thoracique : pneumothorax
- Thrombi dans artères pulmonaires : embolie pulmonaire

Conclusion : la dyspnée aiguë est un symptôme très fréquent, de causes multiples. Elle représente un des principaux symptômes de maladies cardiaques, pulmonaires et autres qui peuvent être graves et rapidement menacer le pronostic vital. Symptôme important qui nécessite une approche méthodique pour orienter un diagnostic et établir un traitement rapide.